

TEMA 9.57 • RESPIRATORIO

Estridor Congenito

PERFIL EUNACOM 2.09.1.001

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

El **estridor congénito** es un ruido respiratorio rudo, generalmente de tonalidad aguda, que se produce debido a una obstrucción parcial de la vía aérea superior en el recién nacido o el lactante pequeño. Aunque existen múltiples causas, la gran mayoría de los casos corresponden a cuadros benignos de resolución espontánea. Sin embargo, el rol del médico es descartar malformaciones o lesiones que comprometan la vida o el desarrollo del niño.

Etiología del Estridor Congénito

El estridor no es un diagnóstico en sí mismo, sino un signo clínico que obliga a buscar una causa anatómica o funcional.

TABLA 9.57.1: FRECUENCIA VS PATOLOGÍA			
FRECUENCIA	PATOLOGÍA	LOCALIZACIÓN	CARACTERÍSTICAS
Muy Frecuente	Laringomalacia	Supraglótica	Colapso de tejidos supraglóticos durante la inspiración.
Frecuente	Hemangioma Subglótico	Subglótica	Crecimiento vascular; puede asociarse a hemangiomas cutáneos.
Menos frecuente	Membrana Laríngea	Glótica	Malformación (banda de tejido) que une las cuerdas vocales.
Raro	Quistes ductales	Supraglótica	Obstrucción mecánica por colecciones líquidas.
Raro	Parálisis de cuerdas vocales	Glótica	Puede ser uni o bilateral (asociado a trauma de parto o cirugía).

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la Laringomalacia: Se produce por una inmadurez o debilidad de los cartílagos laríngeos y de los tejidos de soporte. Durante la inspiración, la presión negativa generada por el tórax hace que las estructuras supraglóticas (como la epiglotis o los aritenoides) sean "succionadas" hacia la luz laríngea, provocando la vibración y el ruido característico.

Diagnóstico: El rol de la Nasofibrolaringoscopia

Ante cualquier lactante con estridor congénito, la conducta clínica mandatoria es la evaluación por especialista para realizar una **nasofibrolaringoscopia**.

- **Evaluación Clínica:** Determinar si hay compromiso del estado general, dificultad respiratoria o problemas de alimentación.
- **Procedimiento:** Se introduce una fibra óptica flexible por la nariz hasta la laringe.
- **Objetivo:** Permite visualizar la vía aérea en movimiento (dinámica).
- **Hallazgos en Laringomalacia:** Se observa una epiglotis en forma de "omega" (Ω) o el colapso de los cartílagos aritenoides hacia el interior de la glotis durante la inspiración.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Aunque la laringomalacia es la causa más común, **nunca se debe asumir el diagnóstico sin una visualización directa**. Es fundamental descartar otras causas como el hemangioma subglótico o membranas, que podrían requerir intervenciones quirúrgicas o farmacológicas urgentes.

Laringomalacia: La causa más frecuente

La laringomalacia representa aproximadamente el 60-70% de los casos de estridor congénito.

Clínica Clásica

- **Estridor inspiratorio:** Es el signo cardinal. Suele ser de tonalidad aguda.
- **Cronología:** No siempre está presente al nacer. Es muy común que aparezca a los pocos días de vida o incluso a las **2 semanas de edad**.
- **Dinámica:** El ruido suele empeorar cuando el lactante está en decúbito supino (de espaldas), llorando o agitado, y mejora cuando está en decúbito prono (boca abajo) o tranquilo.
- **Estado General:** El paciente suele verse **sano** ("suena feo pero se ve bien"). No suele presentar cianosis ni retracción costal severa en casos típicos.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Perla EUNACOM: Si te presentan un lactante de 2 semanas que "ronca" o tiene un ruido agudo al inspirar, que aumenta al llorar pero que **alimenta bien y gana peso normal**, la respuesta más probable es **Laringomalacia**.

Clasificación del Estridor según su localización

La tonalidad y el momento del ciclo respiratorio en que ocurre el estridor nos orientan hacia el nivel de la obstrucción: - **Estridor Inspiratorio:** Sugiere obstrucción **Supraglótica** (ej. Laringomalacia). - **Estridor Bifásico (Inspiratorio y Espiratorio):** Sugiere obstrucción a nivel de la **Glotis o Subglotis** (ej. Estenosis subglótica, membranas). - **Estridor Espiratorio:** Sugiere obstrucción en la **Tráquea** (ej. Traqueomalacia o cuerpo extraño).

Manejo y Pronóstico

El manejo depende estrictamente de la severidad del cuadro y del impacto en el desarrollo del niño.

- **Casos Leves/Moderados (90%):**
 - Conducta: **Observación y espera**.
 - Educación a los padres sobre la benignidad del cuadro.
 - Seguimiento estricto de la curva de peso.
 - **Resolución:** Los cartílagos maduran y se endurecen espontáneamente, resolviendo el estridor habitualmente antes de los **12 a 18 meses de vida**.
- **Casos Severos (10%):**
 - Se sospecha si hay **falla en el crecimiento** (dificultad para alimentarse por el esfuerzo respiratorio), episodios de apnea o cianosis, y retracciones severas.
 - Tratamiento: Puede requerir una intervención quirúrgica menor llamada **supraglotoplastia**.

TABLA 9.57.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS

SIGNOS DE ALARMA (DERIVACIÓN URGENTE)
:
Dificultad para succionar o alimentarse
Escaso incremento ponderal (curva de peso plana)
Episodios de cianosis (coloración azulada)
Retracción intercostal o supraclavicular marcada
Estridor que progresa rápidamente en intensidad

Diagnóstico Diferencial Importante: Hemangioma

Subglótico

Es vital recordar el **hemangioma subglótico**, ya que, a diferencia de la laringomalacia, esta lesión puede crecer rápidamente durante los primeros meses de vida y obstruir la vía aérea de forma crítica.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Aproximadamente el 50% de los niños con hemangioma subglótico tienen también **hemangiomas cutáneos** (especialmente en el área de la "barba"). Si ves un lactante con estridor y un hemangioma en la cara/cuello, sospecha fuertemente compromiso de la vía aérea.

Resumen para el examen

- **Causa #1 de estridor congénito: Laringomalacia.**
- **Tipo de estridor:** Inspiratorio, agudo.
- **Diagnóstico de elección:** Nasofibrolaringoscopia.
- **Tratamiento estándar:** Observación (resolución espontánea al año o año y medio).
- **Principal preocupación:** Asegurar que el niño se alimente bien y gane peso. Si no lo hace, sospechar severidad o diagnóstico alternativo.

Artículos relacionados: **Insuficiencia Respiratoria en Pediatría, Crup Laringeo, Malformaciones Congénitas de la Vía Aérea.**

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un recién nacido de 3 semanas de vida es llevado a consulta porque sus padres notan un ruido respiratorio que apareció hace una semana. El niño se alimenta bien, sube de peso adecuadamente y no presenta dificultad respiratoria. Al examen físico se ausculta un estridor inspiratorio de tonalidad alta que aumenta con el llanto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Estridor Congénito. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La laringomalasia es la causa más frecuente de estridor congénito y es una condición benigna
- Siempre se debe estudiar la causa del estridor congénito con nasofibrolaringoscopia
- La clínica clásica es estridor inspiratorio en un recién nacido que se ve bien pero suena mal
- Las causas supraglóticas producen estridor inspiratorio; las glóticas pueden ser bitonales de tonalidad alta
- El estridor puede no estar presente desde el nacimiento, apareciendo días o semanas después
- En la nasofibrolaringoscopia se observan cartílagos blandos que tienden a colapsar en inspiración
- La laringomalasia resuelve espontáneamente antes del año o año y medio de vida
- Otras causas incluyen hemangioma laríngeo y membrana laríngea, que requieren manejo más activo

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ESTRIDOR CONGENITO)

PREGUNTA 1

Un recién nacido de 3 semanas de vida es llevado a consulta porque sus padres notan un ruido respiratorio que apareció hace una semana. El niño se alimenta bien, sube de peso adecuadamente y no presenta dificultad respiratoria. Al examen físico se ausculta un estridor inspiratorio de tonalidad alta que aumenta con el llanto. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- A) Tranquilizar a los padres e indicar que no requiere estudios
- B) Solicitar radiografía de cuello anteroposterior y lateral
- C) Realizar nasofibrolaringoscopia para confirmar la causa del estridor
- D) Hospitalizar para observación y monitoreo continuo
- E) Iniciar tratamiento con corticoides inhalados

PREGUNTA 2

Una madre consulta preocupada porque su hijo de 2 semanas presenta un ruido al respirar que no estaba presente al nacer. El pediatra realiza una nasofibrolaringoscopia que muestra cartílagos laringeos blandos que colapsan parcialmente durante la inspiración. El lactante se encuentra en buen estado general. ¿Cuál es el manejo indicado?

- A) Cirugía correctiva de los cartílagos laringeos
- B) Corticoides sistémicos por 7 días
- C) Observación y seguimiento, ya que resuelve espontáneamente antes del año a año y medio de vida
- D) Intubación preventiva por riesgo de obstrucción de vía aérea
- E) Antibióticos profilácticos para prevenir sobreinfección

PREGUNTA 3

Respecto al estridor congénito, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA?

- A) Siempre está presente desde el momento del nacimiento
- B) La causa más frecuente es el hemangioma subglótico
- C) El estridor de causas supraglóticas suele ser de tipo espiratorio
- D) La laringomalasia puede manifestarse días o semanas después del nacimiento
- E) El manejo de la laringomalasia siempre es quirúrgico

RESUMEN: ESTRIDOR CONGENITO

Esta clase aborda el estridor congénito, un tema breve pero importante en pediatría y otorrinolaringología. El estridor congénito tiene múltiples causas, siendo la más frecuente la laringomalasia, que es una condición benigna. Sin embargo, existen otras causas potencialmente más graves como el hemangioma laríngeo (subglótico o supraglótico), la membrana laríngea y otras malformaciones, lo que obliga a estudiar siempre la causa con nasofibrolaringoscopia. La laringomalasia se presenta clásicamente con estridor inspiratorio (las causas supraglóticas suelen producir estridor inspiratorio, mientras que las glóticas pueden ser bitonales y de tonalidad alta). Lo característico es un recién nacido que se ve bien pero que suena mal, sin afectación respiratoria real. El estridor puede no estar presente desde el nacimiento, pudiendo aparecer días o incluso un par de semanas después. En la nasofibrolaringoscopia se observan cartílagos laringeos blandos que tienden a colapsar durante la inspiración sin llegar a obstruir la vía aérea inferior. El manejo es expectante, ya que la laringomalasia resuelve espontáneamente a medida que los cartílagos maduran, habitualmente antes del año o año y medio de vida.